ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUで知っておくべき臨床倫理

臨床倫理の入口と地図 — 4原則と4分割法・意思決定能力と代理意思決定・ACPとGoals of Care・DNARの正しい理解・差し控えと終了・家族との対話・蘇生の倫理・医療者を守る・死の判定と臓器提供・公正と高齢者

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-14

ICUの臨床倫理は、特別な症例のときだけ開く分野ではありません。挿管するか、DNARをどう扱うか、家族にどう話すか、治療をどこまで続けるか。毎日の判断の多くに倫理の問いが含まれています。この資料は臨床倫理全体の**入口と地図**で、ガイドラインや論文が更新されるたびに直していく最新版の資料です。各章で骨格を示し、詳しい手順は専用の資料に渡します。

✓ 要点 — この資料の中心原則

相手に選ばせず、医師から提案する。ただし状況に応じて提案の強さを変える。提案と誘導を分けるのは、その土台に本人の価値観があるかどうかです。価値観を聴かずに推奨すれば誘導になり、価値観を聴いたうえで推奨すれば、価値観を医療行為に翻訳した提案になります。だから順番は、病状を伝える → 価値観を聴く → 専門家として推奨する、です [Lu MayoClinProc2020] [AHA2025 倫理編]。提案の強さの5段階と、強さを選ぶ3つの要素は§2にまとめました。

✓ この資料の位置づけ — 詳しくはこちらへ

- 生命維持治療の差し控え・終了の実務（面談・選び方・緩和的抜管・看取り）→ ICUの終末期と意思決定
- 4学会合同ガイドライン（2026）の要点 → エグゼクティブサマリー（A4）／講義スライド／解説ページ
- 高齢者・フレイル → フレイルと高齢重症患者／神経予後の伝え方 → 心停止後ケア／家族とスタッフのケア → ICUの人間的ケア・PICSとICU退室後のフォロー

最新の動き（随時更新）

この領域は2025〜2026年に大きく動きました。日本では4学会合同ガイドラインが10年ぶりに全面改訂され、DNARの射程も学会が明文化しました。新しい順に並べます。行が増えたら、本文の該当章も更新します。

表1｜臨床倫理の最新の動き — 新しい順

時期	出典	要点
2026-09	日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会「生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン」	2014年の3学会の提言を全面改訂。終末期を定義せず、多職種の臨床倫理的検討とSDMの2本柱で決める。差し控えと終了は倫理的に同等、「中止」は「終了」に。DNARは心停止時のCPRに限る。緩和ケア別編で抜管時の薬まで示した（§7）
2026-09	JAMA（脳死を家族にどう伝えるか）	「生命維持装置」ではなく「臓器を支える治療」と言い換える。判定に立ち会った家族は理解の満点到達が66%対20%と高く、心理的負担は増えなかった（RCT 1本）（§11）
2026-09	Critical Care（Perspective）	無益なCPRを短時間だけ行う「time-limited code」は、誠実さも害の軽減も満たさず、倫理的な妥協にならない（§9）
2026-08	Critical Care（Perspective）	死の判定で確認しているのは irreversibility（戻せない）ではなく permanence（もう戻さないという決定）（§11）
2026-08	Intensive Care Medicine（SSC2026のエディトリアル）	敗血症ガイドラインが goals of care・事前指示・期限付き治療（TLT）・緩和ケアを Good Practice Statements として明文化した
2026-08	Critical Care（28研究の質的系統的レビュー）／Crit Care Explor	臓器提供に立ち会う家族を最も傷つけたのは手順の設計。死亡告知と提供の依頼を分ける。心停止後提供でも終末期ケアの中身は変えない（§11）
2026-06	Critical Care Medicine（34論文の系統的レビュー＋エディトリアル）	スローコードは82.4%が「欺瞞」と判断。蘇生を強制する法や方針も同じく非倫理的（§9）
2026-06	Critical Care Medicine（PICNL-ICU、オランダ47 ICU）	医療者の26%が「不適切な治療をしている」と感じていた。複数人が一致した患者は6か月死亡 aOR 3.86（§10）
2026-06	Intensive Care Medicine（SCCM2026・ESICM2025 高齢ICU患者のエディトリアル）	強い推奨はゼロ。一致したのは「老年医学的ケアモデルをICUに組み込む」だけ（§12）
2026-02	Journal of Intensive Care（豪州の終末期ケア）	豪州では差し控えと終了は法的に同等で、家族は無益な治療を要求できない。ただし無益の判断は担当専門医の合意が条件（§12）
2025-10	AHA 2025 心肺蘇生ガイドライン 倫理編（Circulation）	4原則を均衡の枠組みとし、年齢を生命維持治療を制限する唯一の決定因子にしない。informed nondissent（反対がなければ医療者の方針で進める）を示し、スローコードを否定した（§2・§6）
2025-06	JAMA Network Open（4学術病院122人の面接）	モラルディストレスを生むのは病院文化・階層・「治療を減らす手続き」の不在。デブリーフィングは緩和であって予防ではない（§10）

時期	出典	要点
2025-02	Critical Care Medicine（SCCM 成人ICUの家族中心ケアガイドライン2024）	17ステートメントのうち強い推奨は1つだけ。面会を緩和した方針をICUの既定にする（§8）
2025-02	日本救急医学会雑誌（高齢者救急に関する用語の統一概念）	DNAR指示が有効なのは心停止時のみ。BSCをDNARや緩和ケアの言い換えに使わない。「予想された急変」を定義（§6）

時期は論文の公開月です。出典の詳細は末尾の主要文献にあります。

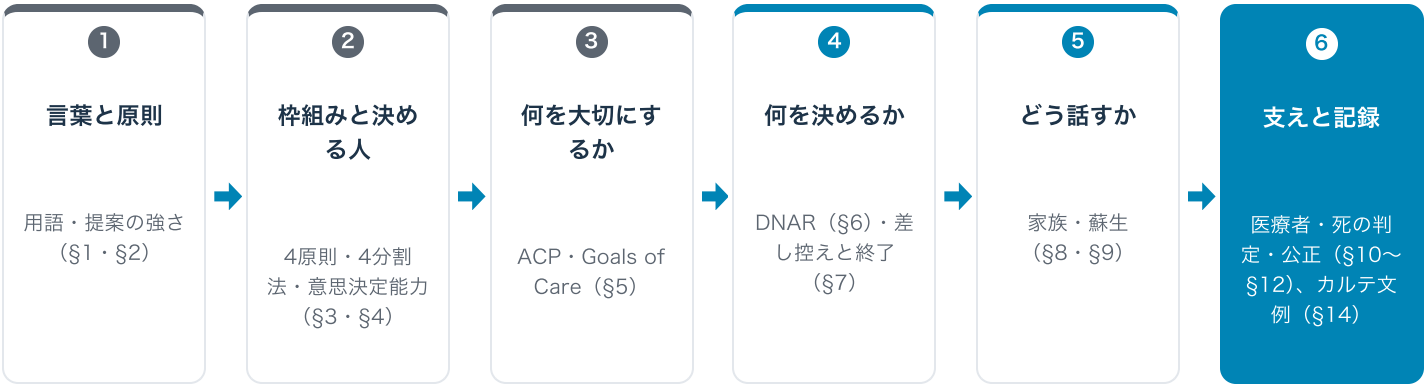


図1. ICUの臨床倫理の地図 — 枠組み → 決める人 → 価値観 → 決める中身 → 話し方 → 支え。

図の読み方 — 左の3段は、治療の話をする前にそろえておく前提です。「何を決めるか」から先に始めると、DNARの拡大解釈や「全部やるか、やらないか」の二者択一に陥りやすくなります [4学会GL2026]。

§1 用語の定義と使い方 — 同じ言葉を同じ意味で使う

臨床倫理の議論が噛み合わない原因の多くは、病態の複雑さではなく言葉のずれです。同じ「DNAR」を医師と看護師が違う範囲で読んでいれば、どれだけ話し合っても合意は形になりません。最初に言葉をそろえます。

この章のポイント

1. **DNARは心停止時だけの指示で、「治療をしない」ではない**
2. **「中止」ではなく「終了」、終末期は判断の根拠にしない**
3. **推定意思と「家族の希望」を分けて記録する**

表2｜臨床倫理の用語 — 定義・使い方と、避ける言い方

用語	定義・使い方	避ける言い方
DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）	心停止時に心肺蘇生（胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬）を試みない指示。有効なのは心停止時だけで、「治療をしない」ではない [JSICM勧告2017]	「急変時DNR」「DNARなので挿管しない」
partial DNAR	胸骨圧迫だけ行って挿管しない、といった部分的な蘇生。救命につながらないので行わない [JSICM勧告2017]	「心マだけ」
スローコード	意図して不完全に行う形だけの蘇生。患者への危害で、家族への欺瞞にあたる。行わない [AHA2025 倫理編]	「形だけやる」
差し控え／終了	開始しないこと（withholding）と、行っている治療をやめること（withdrawal）。倫理的には同等に扱う。「中止」ではなく「終了」と書く [4学会GL2026]	「治療中止」
終末期	4学会GLはあえて定義しない。終了・差し控えは終末期に限らず、治療・ケアのゴールから判断する [4学会GL2026]	「終末期なので」を判断の根拠にする
Goals of care（治療・ケアのゴール）	本人の価値観に照らして治療で何を目指すか（延命・機能回復・苦痛の緩和・自宅に帰る など）。個々の介入の可否そのものではない [Secunda JGIM2020]	「GOC＝DNARの確認」
無益（futility）	その人にとって利益が見込めないこと。医療資源やコストの話ではない	「もったいない」「意味がない」
ACP（人生会議）	本人の価値観を家族・医療者と共有し続けるプロセス。書類を作ることではない [厚労省GL2018]	「ACPを取る」
SDM（共同意思決定）	価値観を聴く段階は本人・家族が主導し、選択肢を勧める段階は医療者が主導する、という役割分担で一緒に決める [Elwyn BMJ2010]	選択肢を並べて選ばせる
推定意思	本人が意思を示せないとき、家族等の話から推定する本人の意思。「家族の希望」とは区別して記録する	「家族がDNARを希望」
家族等	法的な親族に限らず、本人が信頼する人（親しい友人など）を含む [厚労省GL2018]	—
informed assent	価値観と病状を踏まえて医療者が「○○はしません」と方針を伝え、質問を受ける。無益性が明らかで価値観もはっきりしているときに使う [Curtis JAMA2020]	—
informed nondissent	医療者が方針を示し、反対があれば言ってもらい、なければその方針で進める。拒否権を明示して残す [AHA2025 倫理編]	—
informed consent	選択肢と推奨を説明し、同意を得る。ICの主体は患者	「医師が患者にICした」

用語	定義・使い方	避ける言い方
TLT（time-limited trial）	期間と評価項目を決めて特定の治療を試行し、結果で継続・増強・減弱・終了を決める [4学会GL2026]	「とりあえず様子を見る」

ほかに、DNRはDNARの旧来の呼び方、フルコードは心停止時にCPRを行う方針を指します。「延命治療」「BSC」「消極的安楽死」は使いません（§6）。

§2 中心原則 — 選ばせずに医師から提案し、提案の強さを状況で変える

「心臓マッサージを希望しますか」「挿管しますか」。相手を尊重しているように見えるこの聞き方は、ゴールに寄与しないと分かっている選択肢にも検討の価値があるように聞こえさせ、決断の重さを家族に預けてしまいます。この資料全体を通す原則は、価値観を聴いてから医師が提案すること、そしてその強さを状況に合わせて選ぶことです。

この章のポイント

1. **提案と誘導を分けるのは、土台に本人の価値観があるかどうか**
2. **提案の強さは5段階。中立の「どうしますか」は使わない**
3. **強さは、医学的な確かさ・価値観の明確さ・委ねたい気持ちの3つで選ぶ**

2-1. 提案と誘導を分けるのは、価値観を聴いたかどうか

価値観を聴かずに「CPRはしないほうがよい」と言えば、判断が正しくても誘導になります。価値観を聴いたあとなら、同じ言葉は価値観を医療行為に翻訳した提案になります [Lu MayoClinProc2020]。

SDMは、双方が同じ情報を同じように扱うことではありません。価値観を聴く段階では本人・家族が主で医療者は聴き役、治療を選ぶ段階では医療者が主になります [Elwyn BMJ2010]。最初から「はい／いいえ」で聞くと、CPRの次は昇圧薬、透析、人工栄養と、答えようのない質問が続きます [Lu MayoClinProc2020]。

2-2. 提案の強さの5段階

提案には強さの段階があり、強い順に informed assent・informed nondissent・推奨して意見を求める・やや弱い推奨と並び、中立の「どうしますか」はゴールに寄与しないと分かっているときには使いません（表3）。

表3｜提案の強さの5段階 — 強い順。5は使わない

強さ	言い方の例	使う場面・出典
1 informed assent	「そういうことであれば、○○はしません。何かご質問はありますか」	医学的に利益がないことが明らかで、価値観もはっきりしているとき [Curtis JAMA2020]
2 informed nondissent	「○○はしない方針で進めます。反対があればおっしゃってください。なければこの方針で進めます」	拒否権を明示して残し、決定の重荷は医療者が引き受ける [AHA2025 倫理編]
3 推奨して意見を求める	「○○はしないほうがよいと思います。いかがですか」	推奨ははっきり伝え、決定は一緒に行う
4 やや弱い推奨	「○○はおすすめしません」	医学的な見込みに幅があるとき
5 使わない	「○○はどうしますか」（中立の はい／いいえ）	ゴールに寄与しないと分かっているなら、決断を丸投げすることになる

2-3. 強さを選ぶ3つの要素

提案の強さは、医学的な確かさ・本人の価値観の明確さ・家族が決定を医療者に委ねたいか、の3つで選びます。

強さを選ぶ3つの要素

1. 医学的な確かさ — その治療が本人に利益をもたらさないことが明らかか
2. 本人の価値観の明確さ — 価値観を聴く段（§5の Stage 2）で、ゴールが聴けているか
3. 家族が決定を医療者に委ねたいか — 日本では1・2の強さを使う前に、委ねたいかどうかと、どの決定を委ねるかを具体的に確かめる

3つがそろわないときは強さを下げます。価値観が聴けていないなら、提案の前に§5の順で聴き直します。

§3 倫理の基本枠組み — 4原則で名指しし、4分割法で並べる

倫理の問題は「何かがおかしい」という違和感から始まります。その違和感をチームで扱える形にするのが、4原則とJonsenの4分割法です。4原則は対立している価値に名前を付ける道具、4分割法は症例の情報をもれなく並べる道具です。

この章のポイント

1. **倫理的対立は、4原則のどれとどれがぶつかっているかで名指しできる**
2. **症例は4分割法（医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況）で並べる**
3. **生命維持治療は終了されうるが、ケアは終了しない**

3-1. 4原則は、ぶつかっている価値に名前を付ける道具

臨床倫理の4原則は自律尊重・善行・無危害・公正で、ICUの倫理的対立はこのどれとどれがぶつかっているかを必ず同定できます（表4） [FCCS]。

表4｜臨床倫理の4原則 — ICUで問題になる場面

原則	意味	ICUで問題になる場面の例
自律尊重（autonomy）	患者が自己決定する権利	本人が挿管を拒む／意思決定能力が揺れる／事前指示がある
善行（beneficence）	患者にとって最大の利益を生むよう行動する義務	回復の見込みが不確かな治療を始めるか
無危害（nonmaleficence）	利益のない治療・検査で害を与えない義務	苦痛を伴うだけの処置、無益なCPR
公正（justice）	すべての患者を公平・公正に扱う義務	ベッドの配分・トリアージ、障害や年齢による無自覚な差

4原則は答えを出す公式ではありません。たとえば「家族が全部やってほしいと言う」場面は、家族の希望（自律尊重の代理）と、患者に害を与えない義務（無危害）がぶつかっている、と言い換えるだけで議論が進みます。FCCSの教材は、終末期に生命維持は終了されうるが**ケアは決して終了されない**、とまとめています [FCCS]。

3-2. Jonsenの4分割法で、症例をもれなく並べる

4分割法は、症例を医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況の4つの窓から眺めるワークシートで、多職種で議論する前の整理に使います（図2） [Jonsen]。

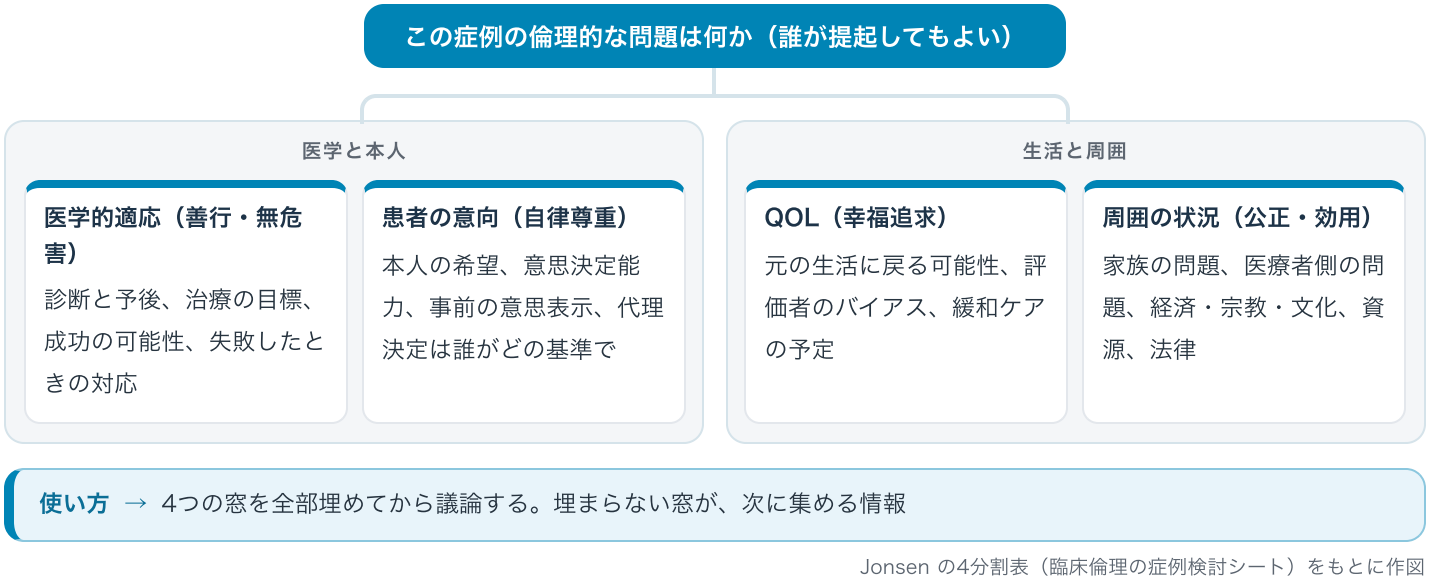


図2. Jonsenの4分割法 — 4つの窓を全部埋めてから議論する。

図の読み方 — 左は医学と本人の窓、右は生活と周囲の窓です [Jonsen]。4学会合同ガイドラインの「臨床倫理的検討の4観点」（医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況）は、この4分割と同じ骨格です [4学会GL2026]。

QOLの窓には「評価者が患者のQOLにバイアスをかけて見ていないか」という問いが入っています。これは§12で扱うエイブリズム（障害への無自覚な先入観）への最初の歯止めです [Jonsen]。

3-3. 対立したら、7つの手順で進める

倫理的対立には、医学的事実の明確化 → 該当する原則の同定 → 意思決定者の明確化 → 誠実なコミュニケーション → コンセンサス形成 → 必要時の倫理委員会 → 記録、という手順で臨みます [FCCS]。

対立したときの手順

1. 医学的事実を明確にする（診断・予後・治療の選択肢）
2. どの倫理原則が関係しているかを同定する
3. 誰が意思決定者かをはっきりさせる（§4）
4. 明確で誠実なコミュニケーションを続ける（§8）
5. チーム内・家族とのコンセンサスを作る
6. 決まらなければ倫理コンサルテーション・倫理委員会に助言を求める（§10）
7. 検討の過程を記録する（§7）

§4 意思決定能力と代理意思決定 — 能力は決定ごとに、代理は本人の意思に近づける

誰が決めるのかが曖昧なまま話し合いを始めると、議論は必ず迷走します。ICUでは鎮静・せん妄・挿管で本人の意思が見えにくくなりますが、「話せない」と「決められない」は同じではありません。

この章のポイント

1. **意思決定能力は全か無かではなく、決定ごとに評価する**
2. **医学的助言に反する選択は、それだけで能力欠如の根拠にならない**
3. **代理意思決定は「家族の希望」ではなく「本人ならどう考えるか」**

4-1. 意思決定能力は、決定ごとの臨床判断

capacity（意思決定能力）は決定ごとに医療者が行う臨床判断で、competency（行為能力）は裁判所が下す法的判断です[Ganzini JAMDA2004]。

能力は診断名でも検査の点数でもなく、その決定について①選択を伝えられる、②理解する、③自分のこととして認識する、④比較して考えられる、の4つの過程で評価します。医学的助言に反した選択をしたこと自体を、能力欠如の根拠にしてはいけません[Ganzini JAMDA2004]。ベッドサイドではCURVESの語呂も使われます（表5）。

表5｜意思決定能力の評価 CURVES — 全か無かではない

項目	確かめること
C：Choose	複数の治療方針から自由に選択できるか
U：Understand	治療の利益・害、代替手段、治療による変化を理解できるか
R：Reason	受け入れる／断る理由を説明できるか
V：Value	本人の価値判断と決定が矛盾していないか
E：Emergency	本当に差し迫った状況か
S：Surrogate	代理人、または本人の意思を記した文書があるか

認知機能が低下していることは、意思決定能力がないことと同じではありません。「ない」という判断は容易には下せません [CURVES]。

4-2. ICUでは能力が時間で動く — 清明な時間を選び、具体的に記録する

せん妄と鎮静で能力は数時間単位で動くので、清明な時間帯に面談を合わせ、緊急でなければ回復を待ちます [Ganzini JAMDA2004]。

4学会合同ガイドラインも、鎮静薬や挿管で能力が一時的に低下して見えることがあり、説明の工夫や環境調整で可能な限り引き出すこと、能力が十分でなくても価値観や選好は持っていることが多い、と書いています [4学会GL2026]。カルテには「意思決定能力なし」とだけ書かず、どの決定について・いつ・どの能力が確認できなかったかを具体的に残します [Ganzini JAMDA2004]。

4-3. 代理意思決定は、本人の意思にどこまで近づけるかで4場面に分ける

厚生労働省のプロセスガイドラインに沿い、本人の意思が確認できる／確認できないが推定できる／推定もできない／身元不詳や身寄りがない、の4場面ごとに進め方を変えます [4学会GL2026]。

2018年の改訂で、意思を推定する「信頼できる者」は家族から**家族等**（親しい友人など）に広がりました [厚労省GL2018]。代理の人に問うのは「ご家族はどうしたいですか」ではなく「ご本人ならどう考えるでしょうか」です。決定の重荷を代理の人に負わせない話し方は§8で扱います。日本では事前指示に法的効力がなく、意思決定代理人の法的な定めもありません。成年後見人に医療同意権は含まれないと一般に理解されています。

§5 ACPとGoals of Care — 価値観を先に聴き、治療の話は最後に

治療の選択肢から話し始めると、話は「生きるか死ぬか」の二択になります。先に聴くべきは、その人が何を大切にして生きてきたかです。ACPはそれを事前に、Goals of Care（GOC）はそれをいま目の前の治療に結びつけます。

この章のポイント

1. **ACPは書類ではなく、繰り返す話し合いのプロセス**
2. **GOCは医療の包括的な目標で、個々の介入の可否ではない**
3. **病状 → 価値観 → 推奨の順に進め、価値観の段を飛ばさない**

5-1. ACPは、繰り返し話し合い、そのつど共有するプロセス

2018年の厚生労働省ガイドライン改訂は、本人の意思は変わりうるので、望む医療・ケアや生き方を日頃から繰り返し話し合い、そのつど文書にして本人・家族等・医療ケアチームで共有することを求めました [厚労省GL2018]。

同じ改訂で、名称は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」となり、在宅や介護の現場も対象に入りました。意思を伝えられなくなる前に、意思を推定する人を決めておくことも求めています [厚労省GL2018]。

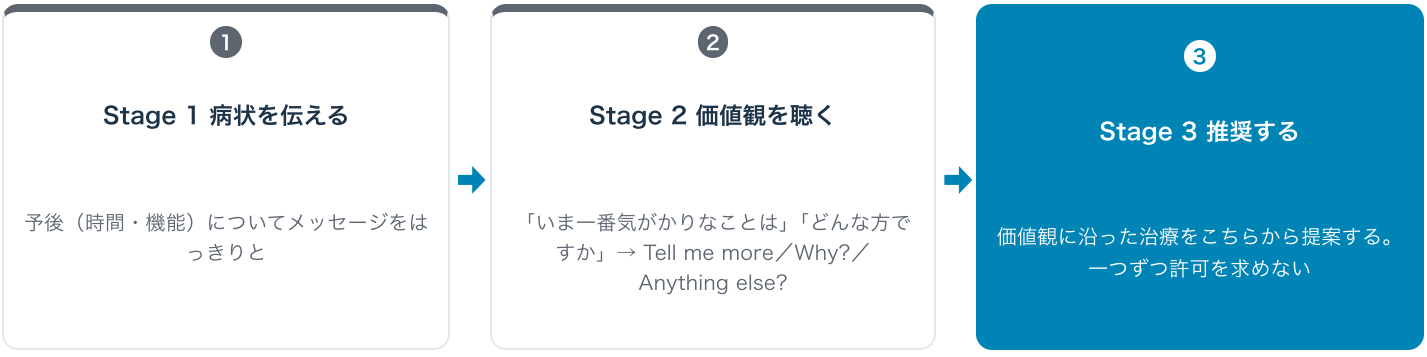
5-2. GOCは「医療の包括的な目標」で、人工呼吸の可否そのものではない

文献の合意によるGOCの定義は、患者の価値観に基づき臨床的文脈のなかで定められる医療の包括的な目標で、個別の介入判断そのものではありません [Secunda JGIM2020]。

「GOCを話す」と宣言した会話でも、患者の価値観に触れる発話は全体の4%未満だったという実測があります [Secunda JGIM2020]。GOCという言葉を使っただけでは、価値観を聴いたことにはなりません。

5-3. 3ステージで話す — 病状、価値観、推奨の順

3ステージプロトコルは、病状の説明 → 治療ゴールの設定（価値観を聴く）→ 治療オプションの相談、の順に進め、手前の段を済ませてから次に進みます（図3） [Lu MayoClinProc2020]。



Lu E, Nakagawa S. Mayo Clin Proc 2020 の3ステージプロトコルをもとに作図

図3. 3ステージプロトコル — 最も飛ばされやすいのは Stage 2。

3つの段では主導する側が入れ替わります。Stage 2 では患者・家族が主で医療者は聴き役、Stage 3 では医療者が主で、聴き取った価値観を医療行為に「翻訳」して推奨します。SDMは、双方が同じ情報を同じように扱うことではありません [Elwyn BMJ2010]。最初から「はい／いいえ」で聞くと、CPRの次は昇圧薬、透析、人工栄養…と、患者側には答えられない質問が延々と続きます [Lu MayoClinProc2020]。

> **図の読み方** — よくある失敗は、Stage 1 の直後に「人工呼吸器をつけますか。ご家族で相談してください」と Stage 3 に飛ぶことです [Lu MayoClinProc2020]。Stage 2 を飛ばすと議論が生死の二択になり、差し控えや終了の判断が極めて難しくなります。

× 許可を一つずつ求める

「心臓マッサージはどうしますか」「抗菌薬を続けたいですか」

○ 価値観に沿って推奨する

「抗菌薬は続けましょう。ただ、苦しませないために心臓マッサージはしません。よろしいですか」

5-4. ACPは事前指示書を作ることではなく、価値観を家族と共有し続けること

事前指示書が実際に効くには、本人が自分の価値観を分かっている・代理人がいる・代理人がそれを知っている・書類がある・その場に書類と代理人がある・医師が適切に話を進める、という条件がすべてそろう必要があります [ACP書籍2024]。

各条件が9割の確率で満たされても、全部そろうのは0.9の7乗で約48%にとどまります。書類を作ったことで「もう話さなくてよい」となり、家族が本人の思いを聞く機会を失うこともあります [Auriemma JAMAInternMed2022]。だから根幹は、本人が自分の価値観を言えることと、それを**できるだけ多くの家族と共有しておくこと**です。元気なうちに将来の治療の選択（Stage 3）まで決める必要はなく、その時が来たら、共有された価値観をもとに家族と医療者で選びます [ACP書籍2024]。

表6｜ACPで尋ねる4つの質問 — 望む上限と、許容できる下限を探る

順	尋ねること	ねらい
1	楽しみにしていること	上限を探る。「価値観は」と聞くより答えやすい
2	生きがい	大切にしているものをさらに深く聞く
3	状態が悪くなったときに一番気がかりなこと	下限に向かう。「悪くなったとき」という前置きをこちらから添える
4	こうなったら生きていたくない、という状態	許容できる下限。伝わらなければ具体例を挙げる

4番目の質問は、死が差し迫ったICUの場面では文脈に合わないので使わず、Stage 2 の他の質問で下限を探ります [ACP書籍2024]。

5-5. 事前指示があっても、ICUの判断に届くとは限らない

フランスの生命維持治療の制限カンファレンス15回では、事前指示を表明していた患者は0名、自分で意思表示できた患者は1名でした [Tarcy ICM2022]**。**

事前指示書の枚数を成果にすると、この落差を見落とします。大切なのは、ICUに入ったあとも価値観を聴き、記録に残し続けることです。

§6 DNARの正しい理解 — 価値観を聴いてから推奨し、範囲を明示した指示にする

DNARは、この資料の中心にある考え方がいちばん試される場面です。DNARの拡大解釈は日本で最も多い誤りの一つで、学会が名指しで警告しています。一方で、「DNARの患者が予期せず心停止したら蘇生するか」という問いでは、現場の意見が今も割れます。割れる原因は、話し合ったかどうかではなく、合意の中身が詰まっていないことにあります。この章は、価値の判断を事前の話し合いで済ませ、ベッドサイドでは迷わない指示にするための考え方をまとめます。

この章のポイント

1. **DNARの範囲は心停止時のCPRだけ。通常の治療は控えない。部分的DNARとスローコードはしない**
2. **フレイルなどの医学的な見込みは判断の材料で、結論は本人の価値観から出す**
3. **価値の判断は事前に済ませ、原因をその場で問わない範囲の明確な指示にしておく**

6-1. DNARの土台 — 範囲は心停止時だけ、通常の治療は控えない

DNARは心停止時に心肺蘇生（胸骨圧迫・除細動・気管挿管など）を試みない指示で、有効なのは心停止時だけです。酸素・挿管・人工呼吸・昇圧薬・抗菌薬・輸液・栄養・ICU入室を、DNARを理由に自動的に差し控えてはいけません（図4） [JSICM勧告2017] [JJAAM2025]**。**

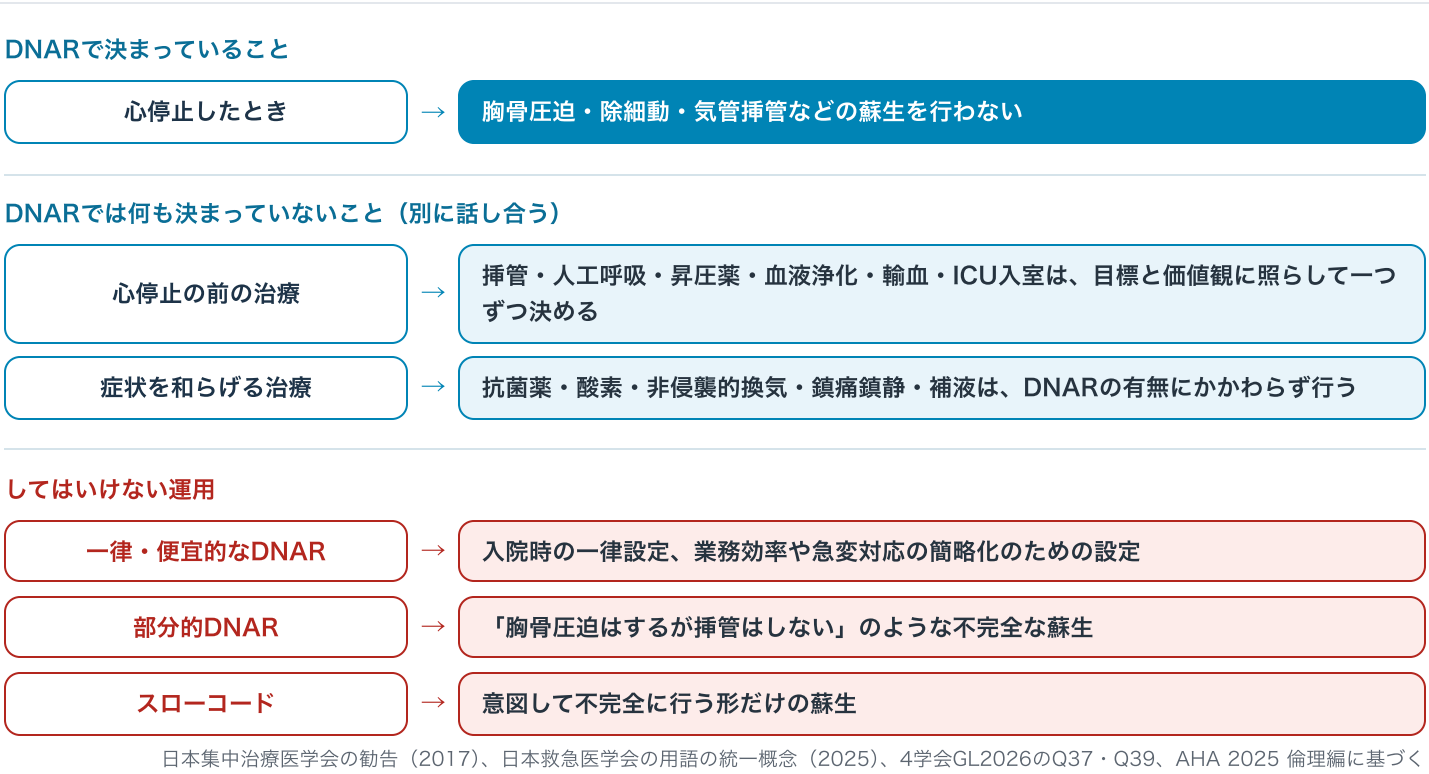


図4. DNARの範囲 — 決まるのは心停止時の蘇生だけ。

> **図の読み方** — 上の段だけがDNARの中身です。「心停止」を「急変時」とすり替えないでください [JSICM勧告2017]。下の赤い段のうち、部分的DNARは不完全な蘇生では救命できないこと、スローコードは患者への危害・尊厳の侵害・家族への欺瞞にあたることが理由です [JSICM勧告2017] [AHA2025 倫理編]。

6-2. 「原疾患による心停止だけに適用」という読み方には根拠がない

DNARを原疾患による心停止に限るという読み方は、学会の文書に根拠が見当たらず、日本集中治療医学会の委員会報告は、別の原因（特に医療行為の合併症）で心停止したときの対応を事前に話し合っておくよう求めているだけです [JSICM委員会報告2016]。

この読み方には2つの無理があります。第一に、心停止の原因は多くの場合その場では分かりません。肺炎で酸素を投与されている患者が急に心停止したとき、それが肺炎のためかどうかは判定できず、最初に発見するのはたいてい看護師です。「発見したら原因を問わず蘇生する」なら、それはDNARではなくフルコードです。第二に、医療者がDNARを考える根拠の多くはCPRがその人に利益をもたらさないという見込みで、原因が分からなくてもその見込みは変わりません。本人が自分の価値観から蘇生を拒むことも、別の正当な根拠です [AHA2025 倫理編]。

6-3. フレイルは医学の問いの材料で、価値の問いの結論ではない

フレイルは院内心停止後の死亡や神経学的転帰の悪さと関連し、「蘇生がうまくいくか」という医学の問いの材料になりますが、「この人にとって蘇生が最善か」という価値の問いには答えません（表7）。

表7｜フレイルと心停止後の転帰 — 関連は強いが、一律の線は引けない

研究	結果
系統的レビュー（7研究1,704例）	フレイルでCPR後の死亡 OR 3.56（死亡率 90.2%対71.6%） [Hamlyn 2022]
60歳超の院内心停止90例	CFS 4超では生存退院0例、非フレイルは26% [Ibitoye]
日本の院外心停止（SOS-KANTO 2017）	発症前のCFSが高いほど30日後の神経学的転帰が悪い [Yamamoto AnnEmergMed2023]

CFSの閾値は研究ごとに異なり（4超、5以上）、小さな後ろ向き研究で「無益」と断定するのは言い過ぎです [Hamlyn 2022]。委員会報告も、後期高齢やADLの低さだけでは終末期とはいえず、それを理由にCPRを差し控えることが正当とはいえないとして、適応がずるずる広がることを警戒しています [JSICM委員会報告2016]。AHA 2025も、年齢を生命維持治療を制限する唯一の決定因子にしないとし、利益がないという判断には価値観が入りうるので、それを引き出す方法としてSDMを置いています [AHA2025 倫理編]。

6-4. 4学会GLの構造 — 終末期を定義せず、範囲の明確なDNARを求める

4学会合同ガイドラインは「終末期」を定義せず、多職種の臨床倫理的検討（医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況の4つ）とSDMの2本柱で治療・ケアのゴールを探るプロセスを示し、入院時に一律に設定するDNARを否定して、DNARは適用範囲が明確であることが不可欠だとしています [4学会GL2026]。

フレイルからの予後の見積もりは、4つの側面のうち「医学的側面」の一つにすぎません。旧ガイドラインの終末期の例示が「線」として読まれ、その外側で考えが止まってしまったことを、作成側は説明文で認めています [4学会GL2026]。「DNARは原疾患の心停止に限る」という読み方も、単一の線で判断を止めるという同じ構造の誤りです。

6-5. 看護師と医師の役割 — 価値の判断は事前に、ベッドサイドでは指示に従う

価値の判断はベッドサイドではなく事前の話し合いの場で済ませ、その結果を範囲の明確な指示にしておけば、心停止を発見した看護師はその場で本人の価値観に立ち返る必要はありません。指示の範囲が曖昧で迷ったときは、蘇生を始めながら確認します [AHA2025 倫理編]。

医師の側は、§5の順で価値観を聴いてから、専門家として方針を推奨します。AHA 2025は informed nondissent を示しました。伺った価値観と病状を踏まえて医療者が方針を示し、反対があれば言ってもらい、なければその方針で進める方法です。家族に決断の重荷を負わせず、医療者が一方的に決めるのでもなく、明確な拒否権を残します [AHA2025 倫理編]。医学的に利益がないことが明らかで価値観もはっきりしているときに、方針を伝えて質問を受ける informed assent も同じ考え方です [Curtis JAMA2020]。日本ではまだ一般的ではないので、家族が決定を医療者に委ねたいか、どの決定を委ねるのかを具体的に確かめてから使います。提案の強さの5段階と選び方は§2（表3）にあります。

× 選択肢を選ばせる

「心臓マッサージを希望しますか」「挿管しますか」と、価値観を聴く前に「はい／いいえ」で聞く

○ 価値観を聴いてから推奨する

伺った価値観に照らして最善と考える方針を示し、反対や質問がないかを確かめる

6-6. 窒息と医原性の心停止 — 原因ではなく、事前に合意した範囲で決める

気道が詰まって苦しんでいる段階での異物除去や吸引はCPRではないのでDNARと無関係に行い、窒息で心停止した後にCPRをするかどうかは、原因ではなく事前に合意した範囲で決まります。

例外として事前に検討しておくのは、処置に伴う可逆的な医原性心停止です。原因が分かり可逆性が高く、処置に同意した時点で合併症からの回復は本人のゴールに含まれていると考えられます。日本集中治療医学会の調査では、DNARのある80歳の心不全患者が内視鏡中の喉頭痙攣で心停止した場面で、医師の83.4%が「CPRをする」と答えました [JSICM委員会報告2016]。ただし医原性なら自動的に蘇生するのではなく、処置中にDNARを一時的に変更・解除するかを事前に決めておきます。

DNARの指示の書き方 — 一般論としての実装の一案（ガイドラインのルールではない）

1. 心停止時は原因を問わずCPRを行わない（発見者にその場で原因を判断させないため）
2. 窒息による心停止も含む（DNARを考える患者では十分に起こりうるため）
3. 処置に伴う医原性心停止は、処置中にDNARを一時的に変更・解除するかを事前に決める
4. 蘇生を始めた後に本人の望む状態に戻れないと分かれば、速やかに終了を検討する

4学会合同ガイドラインが求めているのは「適用範囲を明確にする」ところまでです。「原因を問わず」は、原因をその場で推定できない現場でそれをどう実装するかの提案で、施設ごとに倫理委員会などで検討して決めるものです。

6-7. TLTとACPは車の両輪 — TLTを免罪符にしない

ACP（事前の対話）とTLT（始めて確かめる仕組み）は車の両輪で、TLTがあれば「フルコードか、何もしないか」の二択から抜け出せますが、「迷ったらとりあえず始める」の免罪符にはなりません [4学会GL2026]。

TLTの主な対象は、心停止時のCPRそのものより、蘇生後の人工呼吸などの生命維持治療です。何を目標に試すか、いつ何で再評価するか、その結果が価値観とどう結びつくかを先に決めておかなければ、「決めきれないから続ける」先延ばしになります。ガイドラインは、ACPの内容が実際の状況と食い違っても、本人の価値観をもとに意思を推定してよいとしています [4学会GL2026]。予期した心停止か予期しない心停止かで線を引く必要は、上流の話し合いがあれば生じません。

6-8. 記録すべき項目と、言葉のそろえ方

DNARの記録には、結論だけでなく、患者の意思と推定意思の根拠、考慮する時期とその根拠、最善の選択肢の検討内容、検討に加わったメンバーを残します [4学会GL2026]。

学会の調査では、DNAR指示そのものの記録は9割にあったのに対し、協議の過程の記録は7割にとどまりました[JSICM委員会報告2016]。範囲と根拠が書かれていなければ、夜勤の看護師には伝わりません。法的にも、適切なプロセスを踏んだ終了・差し控えが刑事裁判で違法とされることはないと考えられるとされ、話し合いの過程の記録が最大の備えになります（§7）[4学会GL2026]。言葉もそろえます（表8）。

表8｜言葉の対応表 — 使わない言葉と、代わりに使う言葉

避ける言葉	代わりに	理由
治療の「中止」	生命維持治療の「終了」	「中止」は再開を前提にすると読まれうる。症状緩和は続くので「生命維持治療の」と付ける
延命治療・延命措置	生命維持治療	どこからが延命か区切れない
BSC（best supportive care）	具体的に何をするかを書く	内容が具体的でなく、「見放した」と受け取られやすい
「ここからは緩和ケアで」	緩和ケアを並行して続ける	緩和ケアは予後ではなく必要性で行う
「医師が患者にICした」	「説明し、同意を得た」	ICの主体は患者。3要素は十分な説明・理解・自由意思に基づく同意
「急変時DNAR」	「心停止時はCPRを行わない」	DNARの範囲は心停止時だけ

日本救急医学会は、担当医が近い将来に生じうると予想できる病態の変化を「予想された急変」と定義し、事前の指示があればそれに従うことも可能としました[JJAAM2025]。

§7 生命維持治療の差し控えと終了 — 2本柱で検討し、3つの選択肢から選ぶ

2026年9月の4学会合同ガイドラインは、「終末期かどうか」で決める枠組みをやめ、手順で決める枠組みに変えました。この章では判断の骨格だけを示します。面談の進め方・選び方・緩和的抜管・看取りの実務は「ICUの終末期と意思決定」にあります。

この章のポイント

1. **終末期を定義せず、多職種の臨床倫理的検討とSDMの2本柱で決める**
2. **差し控え・終了・TLTのどれでも、心停止時のCPRはせず症状緩和は続ける**
3. **差し控えと終了は倫理的に同等だが、臨床経過はまったく違う**

7-1. 判断の2本柱と3つの選択肢

1本目は医療・ケアチームの臨床倫理的検討（4観点）、2本目は厚生労働省ガイドラインに沿った本人・家族等とのSDMで、選択肢は差し控え・終了・期限付きの試行（TLT）の3つです（図5） [4学会GL2026]。

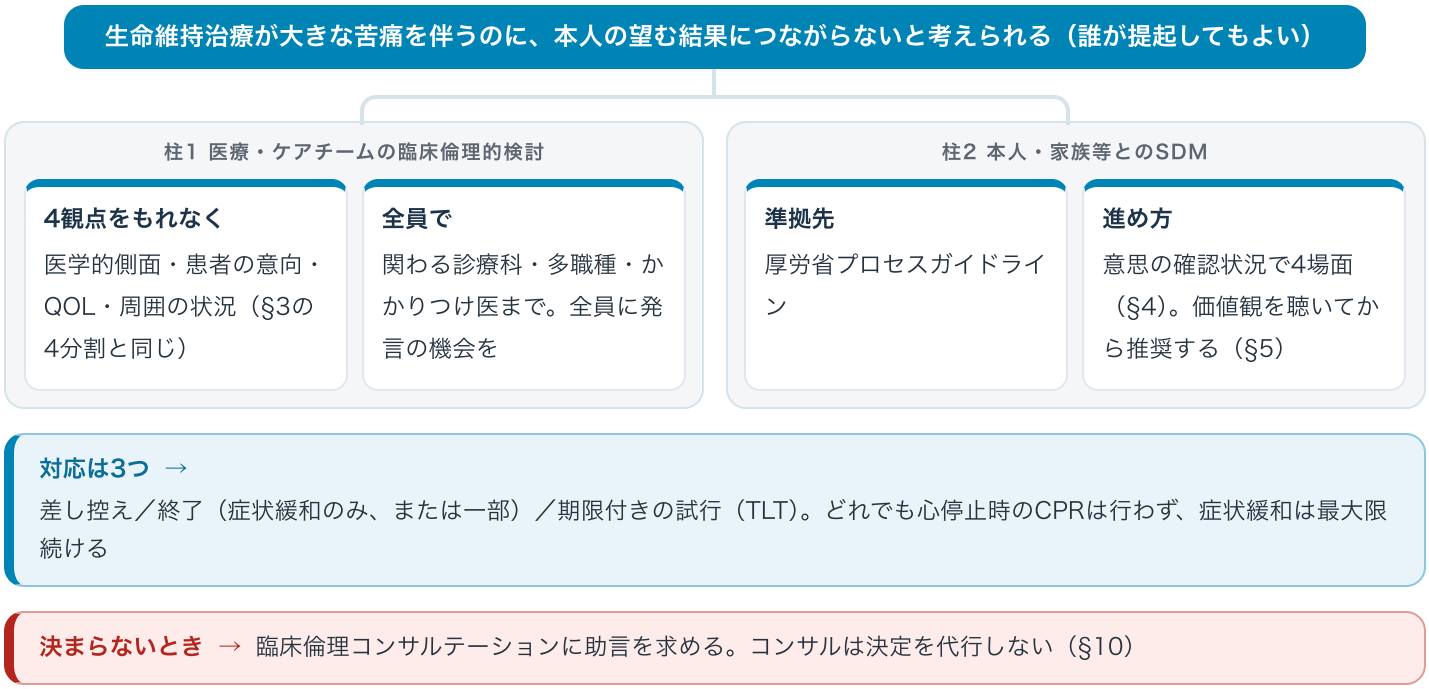


図5. 生命維持治療の差し控え・終了を決める手順 — 2本柱で検討し、3つの対応から選ぶ。

図の読み方 — 左のチーム内の検討と右の本人・家族との話し合いは並行して進めます [4学会GL2026]。患者本人が終了を希望した場合も、自己決定だけに依拠せず、この2本柱で総合的に判断します。

7-2. 差し控えと終了は倫理的に同等 — だから「やめられないから始めない」をしない

倫理的評価は開始か終了かという順序ではなく「その時点で患者にとって適切か」で決まり、死亡の直接の原因は病気であって治療の終了ではありません [4学会GL2026]。

「差し控えは許されても終了は許されない」とすると、家族は予後が読めない急性期に「全部やるか、やらないか」を迫られ、救命できたかもしれない患者の初期治療までためらわれます。ただし臨床経過は別物です。欧州22 ICUのEthicus-2では、差し控え後は約35%が生存退院した一方、終了後は24時間以内に98%が亡くなりました（表9） [Ethicus-2 JAMA2019]。

表9｜Ethicus-2（1999→2016、欧州22 ICU） — 治療制限は例外から標準へ

指標	1999〜2000年	2015〜2016年
治療制限を伴う死	68.3%	89.7%
治療制限後の生存退院	5.5%	20.4%
差し控え後の生存退院	8.9%	34.9%
終了後24時間以内の死亡	—	98%

対象は西欧に偏った22 ICUで、そのまま日本に当てはまるとは限りません [Ethicus-2 JAMA2019]。

7-3. 迷ったらTLT — 目標・期日・価値観を始める前に決める

TLTは家族とチームの意見が違うときや予後が読めないときに使い、何を目標に試すか・いつ何で再評価するか・その結果が価値観とどう結びつくかの3点を先に決めます [4学会GL2026]。

TLTは終了へ誘導する枠組みではなく、期限が来たら自動的に終了するものでもありません。JAMA2011のコメンタリーが示した5要素（臨床問題と予後、患者の目標、改善と悪化の客観的指標、再評価の時間枠、終了時の行動）と同じ骨格です [Quill JAMA2011]。

7-4. 記録は3区分で残す

4学会合同ガイドラインは、医学的な検討とその説明、患者の意思、終了・差し控えを検討する際の対応、の3区分で記録することを求めています [4学会GL2026]。

抜けやすい記録

1. 終了・差し控えを考慮する時期であることと、その根拠
2. 家族等による推定意思と、その根拠
3. 検討に加わったすべてのメンバー（医療・ケアチームを含む）
4. TLTの目標・再評価日・判断の指標

7-5. 法律はないが、手順を守ることが法的な不安への答えになる

日本には終了・差し控えを定めた法律がなく、厚生労働省と学会のガイドラインが拠り所で、2007年以降、救急・集中治療の終末期医療で刑事事件や警察介入が全国報道された案件は確認されていません [4学会GL2026]。

有罪となった事件は、薬剤で意図的に死期を早めた事例でした。ガイドラインに沿った適切なプロセスなら刑事裁判で違法とされることはないと考えられる、と説明文は述べていますが、従えば法的に免責されるとは書いていません [4学会GL2026]。

！このガイドラインの読み方

推奨の強さもエビデンスの確実性も付かない、手順を示す臨床倫理のガイドラインです（作成委員28名の修正デルファイ法3ラウンド）。プロセスが患者・家族のアウトカムを改善するかの実証データは乏しく、手順が守られているかを測る仕組みもまだありません [4学会GL2026]。

§8 家族との対話と対立 — 聴いてから推奨し、対立は層を見立てる

倫理的な判断の多くは、家族との会話の中で形になります。何を決めるかと同じくらい、どう話すかが結果を左右します。対立が起きたときも、「困った家族」と呼ぶ前に、どこで手続きが壊れたかを見にいきます。

この章のポイント

1. **深刻な知らせの直後に、重要な決定を求めない**
2. **決定は「家族が決めた」ではなく「医学的な結論を家族と確認した」と表す**
3. **対立は課題 → プロセス → 関係の順に移る。関係の層に入る前に手を打つ**

8-1. 深刻な知らせの直後、家族の脳は意味を受け取れない

深刻な知らせを聞いた家族では、言葉の意味が届く前にストレス反応が作業記憶と新しい記憶を止めるため、混乱や沈黙は「分かっていない家族」ではなく生理的な過負荷のサインです [Rusinova ICM2026]。

見出しを1文で短く伝えて間を置く、「わかりましたか」ではなく受け取ったことを話してもらう、という工夫が勧められています。ただしこの総説は仮説生成型の概念モデルです [Rusinova ICM2026]。面談の骨格にはSPIKESを使い、Perception → Invitation の順に「まず聞く」こと、感情には解決ではなく言葉で応答すること（NURSE）を押さえます [Baile Oncologist2000]。

8-2. 決定の重荷を家族に負わせない

終了は「家族が決めたこと」ではなく「医学的に到達した結論を家族と確認したこと」として言語化し、記録にもそう残します [Choi CritCare2026]。

「死のタイミングを自分が決めてしまった」という感覚は、医学的に正しい説明をしても消えません。§5の Stage 3 で医療者側から推奨を伝えることは、家族の負担を減らす手段でもあります。

8-3. 選ばせずに提案する — 強さは状況で選ぶ

家族との対話でも中心原則は同じで、相手に選ばせず医師から提案し、提案の強さを状況に応じて変えます。提案と誘導を分けるのは、その土台に本人の価値観があるかどうかです（§2） [Lu MayoClinProc2020]。

ゴールに寄与しないと分かっている治療を「どうしますか」と中立に尋ねると、その選択肢にも検討の価値があるように聞こえ、決断の重さを家族に預けることになります。価値観が明確で医学的にも利益がないことが明らかなら informed assent や informed nondissent を、見込みに幅があるなら推奨して意見を求める形を選びます。強い形を使う前に、家族が決定を医療者に委ねたいかを確かめます（表3） [Curtis JAMA2020] [AHA2025 倫理編]。

× 中立に選ばせる

「人工呼吸器をつけますか。ご家族で相談してください」

○ 価値観を受けて提案する

「伺ったお考えからすると、機械につなぐことはせず、苦しさを取ることに力を注ぐのがよいと考えます。反対があればおっしゃってください」

8-4. 予後は「わかりません」で済ませず、時間の単位で伝える

「どれくらいですか」と聞かれたら、聞く準備ができているかを確かめ、正確には分からないが目安は伝えられると前置きし、数時間〜数日・数日〜数週・数週〜数か月・数か月〜数年のどの単位かで答えます [ACP書籍2024]。

どの単位かの見当もつかないことは、実際にはほとんどありません。伝えた後は沈黙を置き、気まずさから情報を話し足さないようにします。驚きなどの感情が出たらNURSEで応じ、受け止めが済んでいれば価値観の話（Stage 2）に進みます [ACP書籍2024]。

8-5. 対立は3層で見立てる

ICUの対立は「何をすべきか（課題）」→「誰がどう決めたか（プロセス）」→「信頼と敬意が壊れたか（関係）」の3層を移動し、関係の層に入ると解決は格段に難しくなります [Jabaley CritCare2026]。

「困った家族」というラベルを貼る前に、どのプロセスが壊れていたかを見ます。家族に会う前にチーム内で見解をそろえることも勧められていますが、単独の効果を示すエビデンスはありません [Jabaley CritCare2026]。

8-6. 家族支援の研究 — コミュニケーションの質は動くが、心理症状は動きにくい

20年の家族支援RCTは、コミュニケーションの質と在室日数は改善しても、不安・抑うつ・PTSDはほとんど減らせないという結論に収束しています（表10）。

表10｜家族支援の主な研究 — 誰が担ったかで結果が分かれる

研究	介入	結果
PARTNER（NEJM2018）	既存の多職種ICUチームによる家族支援	心理症状は改善せず、コミュニケーションの質とICU滞在は改善 [White NEJM2018]
3ステップ支援戦略（Lancet2022）	死の前後に担当医・看護師が家族と会う	長引く悲嘆 21%→15% [Kentish-Barnes Lancet2022]
SCCM家族中心ケアGL（2024）	17ステートメント	強い推奨は「面会を緩和した方針を既定にする」の1つだけ [Hwang CCM2025]

陽性だったのは既存の医療チームが直接行った介入で、新設の専任役職に担わせた介入は陰性に傾いています。詳細は「ICUの終末期と意思決定」の「どう話すか」の章にあります。

§9 蘇生の倫理 — スローコードは選ばず、心停止の前に話す

「家族が全部やってほしいと言うが、CPRは無益だと思う」。この板挟みで生まれるのが、形だけの蘇生（スローコード）です。2026年、倫理文献の系統的レビューとエディトリアルがこの問題に正面から答えました。

この章のポイント

1. **スローコードは欺瞞で、治療として正当化できない**
2. **短時間だけのCPR（time-limited code）も妥協にならない**
3. **解決は、心停止の前に処置の単位で話すことと、組織の様式を直すこと**

9-1. スローコードは「家族への配慮」ではなく欺瞞

米国の倫理文献34本の系統的レビューでは、82.4%（28本）がスローコードを欺瞞、67.6%が患者への害と判断し、61.8%（21本）が医師は無益なCPRを断ってよいとしました [Fontenot CCM2026]。

賛成側の論拠は家族の情緒的な必要に立脚しており、その慰めは家族が真実を知らないことに依存しています。併走するエディトリアルは、真の問題は個々の医療者ではなく、欺瞞を最良の選択肢にしてしまう法と方針の側にあると指摘しました [Ajzenberg CCM2026]。

× 包括的に聞く

「すべてやりますか」

○ 処置に降ろして、心停止の前に話す

「胸骨圧迫・挿管・電気ショックは、この方の目標の役に立つでしょうか」

9-2. 短時間だけのCPRも、倫理的な妥協にならない

無益なCPRをプロトコルどおり始めて短時間で打ち切る time-limited code は、誠実さを満たさず、害も減らさず、家族の要求のために患者への義務を押しのけるため、倫理的な戦略にならないと論証されました [Wasserman CritCare2026]。

肋骨・胸骨骨折の多くは最初の1分以内に起こり、リスクは前半に集中します。TLTの枠組みが正当なのは本当に不確実なときだけで、無益なCPRへの要求に流用しません。ただしこれはデータではなく倫理的論証です [Wasserman CritCare2026]。

9-3. 蘇生の倫理的問題は、個人ではなくシステムの産物

蘇生をめぐる倫理的問題の大半は、個人の道徳的欠陥ではなく、法的曖昧さ・組織文化・階層・資源制約が生む構造的な産物で、日本でも「DNAR＝心停止時のみ」の拡大解釈が記述されています [EPM ResuscPlus2026]。

医師へのコーチングを行ったCODE試験では、過剰治療の可能性がある患者での書面のDNI-DNACPR決定が29.7%対19.6%に増えましたが、チームの倫理的風土（EDMCQ）の差は0.02点で動きませんでした [CODE ICM2024]。書式を整えるだけでは風土は変わりません。

§10 医療者を守る — モラルディストレスは組織の課題、コンサルは決定を代行しない

「正しいと思うことができない」苦しさ（モラルディストレス）は、個人の弱さではありません。2025〜2026年の研究は、それを組織が生む構造的な現象として扱うべきだと示しました。

この章のポイント

1. **複数の医療者が感じる「不適切な治療」は、予後のシグナルとして扱う**
2. **先に変えるのは権限と手続き。デブリーフィングはその次**
3. **倫理コンサルテーションは助言で、決定を代行しない**

10-1. 医療者の4人に1人が「不適切な治療」と感じている

オランダ47 ICU・医療者1,058人の調査で26%（276人）が当日「不適切な医療を提供している」と感じ、複数人が同じ患者について一致した場合、その患者の6か月死亡は aOR 3.86（95%CI 1.23–12.16）でした [PICNL-ICU CCM2026]。

リスクを高めたのは看護師であること（aOR 1.78）と、終末期の意思決定を避ける文化（aOR 1.92）でした。ただし患者本人のQOLやICU入室の後悔には差がなく、この感覚は「ICUに来るべきでなかった」の根拠にはなりません。違和感を個人の感情として流さず、ゴール・オブ・ケアを見直すきっかけにします [PICNL-ICU CCM2026]。

10-2. 「治療を足す手続きはあるのに、減らす手続きがない」

米国4病院122人の面接は、モラルディストレスを増やす要因として、「ノーと言えない」病院文化、医療階層（主科と専門科の間も含む）、治療を減らす手続きの不在を挙げました [Brender JAMANetwOpen2025]。

緩和する要因は、階層を越えてコンサルを起票できる権限、対立処理と情緒的支援の資源、現場発の改善でした。デブリーフィングは苦痛が生じた後に効く「緩和」で、上流を止める「予防」ではありません [Brender JAMANetwOpen2025]。4学会合同ガイドラインの緩和ケア別編も、医療者のケアとして人員配置と仕事量の管理、困難事例後のデブリーフィング、定期的なスクリーニング、相談体制を挙げ、MMD-HPなどの日本語版尺度を一覧にしています [4学会GL2026]。

10-3. 倫理コンサルテーションは、4つの場面で呼び、決定は代行させない

チームで決まらない、家族等と合意できない、家族等の中でまとまらない、患者の意思が分からず家族等もいない、のいずれかでは臨床倫理コンサルテーションに助言を求めますが、コンサルは決定を代替しません [4学会GL2026]。

安楽死にあたるかもしれないと医療者が悩む場面でも、コンサルテーションや倫理委員会を使いやすい体制が望まれます [ICUとCCU2022]。呼ぶことは失敗ではなく、手続きの一部です。

§11 死の判定と臓器提供 — 告知と依頼を分け、終末期ケアの中身は変えない

治療を終了した後も倫理の問いは続きます。死をどう判定し、どう伝えるか。臓器提供の可能性を、終了の判断とどう切り離すか。2026年はこの領域でも整理が進みました。

この章のポイント

1. **死亡確認で確かめているのは「もう戻さない」という決定（permanence）**
2. **終了の判断が先、臓器提供の提示は後。両者を独立させる**
3. **脳死は「臓器を支える治療」と言い換え、判定への立ち会いを選べるようにする**

11-1. 死の判定はベッドサイドの臨床判断

蘇生を止めて死亡を確認するとき確かめているのは、irreversibility（どんな手段でも戻せない）ではなく permanence（もう戻さないという我々の決定）です [Le Dorze CritCare2026]。

これは基準を緩める話ではなく、基準の適用の仕方を言語化する話です。脳死の説明では「検査で証明されました」ではなく「複数の所見を突き合わせて判断しました」と伝えることが勧められています [Le Dorze CritCare2026]。

11-2. 終了の判断と臓器提供は明確に分ける

4学会合同ガイドラインは、終了の判断と臓器提供を明確に区別し、提供の可能性が終了の判断に影響することは趣旨に反するとしたうえで、方針が整理された後に独立したプロセスとして提示することを求めました（Q79） [4学会GL2026]。

28研究の質的系統的レビューでは、家族を最も傷つけていたのは臨床医の不親切ではなく、死亡告知と提供の依頼を切り離さない手順や書類の山という制度側の設計でした [Choi CritCare2026]。米国の集中治療医のグループは、心停止後提供でも症状緩和の目標・薬剤・用量は変えないと宣言しています（意見論文） [Oppenheim CritCareExplor2026]。

11-3. 脳死を家族に伝える言葉

「生命維持装置」ではなく「臓器を支える治療」、「昏睡」ではなく「回復しない脳の損傷」と言い、判定に立ち会った家族は理解度の満点到達が66%対20%と高く、心理的負担は増えませんでした [Wu JAMA2026]。

複数回の面談を最初から計画すること、判定に関わる医師と臓器提供の担当者を分けることも挙げられています。米国では脳死は法的な死ですが、日本では法的脳死判定は臓器提供を前提とする場合に限って行われます。言葉の選び方の原則は使い、法的な部分は日本の制度で読み替えます [Wu JAMA2026]。

§12 公正・エイブリズム・高齢者 — 年齢や障害で推し量らず、本人に尋ねる

意思決定には、無自覚の前提が入り込みます。「この人は決められない」「この人のQOLはどうせ低い」という思い込みは、4原則の解釈を内側から歪めます。最後の章は、判断の根拠にしてよいもの・いけないものを確かめます。

この章のポイント

1. **障害や医療機器の使用だけを理由に、差し控え・終了を検討しない**
2. **QOLは外見から推し量らず、本人に尋ねる**
3. **高齢者の判断根拠は年齢ではない。強い推奨はまだない**

12-1. エイブリズムを点検する3つの問い

エイブリズムは差別の意図ではなく無自覚の前提として意思決定に入り込むので、面談とカンファで3つの問いを足して点検します [Taccone ICM2023]。

足す3つの問い

1. 「ご本人が普段使っているコミュニケーション手段は何ですか」（入室初日に）
2. 「入院前のベースラインは、何ができる状態でしたか」
3. 「この推奨は、この方に障害がなかったとしても同じですか」（推奨を書く前に）

中等度〜重度の障害を持つ153人の面接では、54.3%が自分の生活の質を excellent または good と評価しました。一方で45.7%はQOL不良と答え、疼痛・倦怠感・コントロール喪失・生きる目的の欠如が共通していました。障害の重さからQOLを一律に推し量らず、本人に直接尋ねます [Albrecht SocSciMed1999]。

12-2. 判断の根拠にしてはいけないもの

4学会合同ガイドラインは、ベッド状況・病院経営・医療資源・収益性・「無益性」を判断根拠とする枠組みを採用せず、障がいの有無や医療機器の使用状況だけを理由に終了・差し控えを検討しないと明記しました（Q47・Q70〜Q76） [4学会GL2026]。

予後モデルに基づいて治療を縮小・終了することも、医療専門職の倫理的責任が禁じるとされています。予後予測は家族と共有する情報として使い、決定は価値観と合意形成で行います。「予測」と「決定」を分けます [Correspondence ICM2023]。

12-3. 高齢者 — エビデンスの薄さを直視する

高齢ICU患者についてSCCM（2026）とESICM（2025）はいずれも強い推奨を出せず、一致したのは老年医学的ケアモデルをICUに組み込むという条件付き推奨だけでした [Beil ICM2026]。

益と負担を語るとき、根拠は年齢ではなく老年症候群の束で、目標は多くの場合、生存期間より生活の質です [Beil ICM2026]。日本のJIPADでは、80歳以上への生命維持治療の使用が施設間で case mix 調整後も約10倍（STR 0.24〜2.34）違い、治療強度の高い施設で生存が良いわけではありませんでした [JIPAD JAMAHealthForum2026]。詳しくは「フレイルと高齢重症患者」へ。

12-4. 法で線を引く国、手続きで線を引く国

豪州では差し控えと終了は法的に同等で、家族は無益な治療を要求できず、事前指示書は家族も覆せませんが、無益の判断は担当専門医の合意が条件です [Ueno JIntensiveCare2026]。

手順の向きは4学会合同ガイドラインとほぼ同じで、違いは日本が家族の合意を実務上の要にし、豪州が法で線を引いている点です [Ueno JIntensiveCare2026]。日本の実務は、対話のプロセスに重心を置く構造にあります。

§13 まだ決着していないこと — 割れている論点をどう扱うか

倫理は「どちらが正しいか」で決まらない領域です。文献の結論が割れている論点を、扱い方とともに並べます（表11）。

表11｜結論が割れている論点 — 矛盾ではなく、次元や場面の違い

論点	割れ方	扱い方
差し控えと終了は同じか	倫理的には同等（4学会GL）／臨床経過は別物（Ethicus-2）	「やめられないから始めない」をしない。記録では項目ごとに書き分ける
予後予測を治療制限に使ってよいか	不良マーカー2つ以上で偽陽性ゼロ／良好転帰33例では95%上限10.6%までしか言えない	予測は情報として共有し、決定は価値観で。「偽陽性ゼロ」と言わない
家族への介入は効くのか	陽性の試験／陰性の試験	誰が担ったかで割れている。既存チームの運用に組み込む
DNAR記載を増やすことは良いことか	コーチングで記載は増えた／一律の記載は否定されている	記載の数を成果にしない
ACP・事前指示は実効性があるか	緩和ケアの統合で事前指示は増えた／15カンファで事前指示0名	文書の枚数ではなく、価値観を聴いた記録を見る

まだ分かっていないこと

- 4学会合同ガイドラインの手順が、患者・家族のアウトカムや意思決定の質を改善するか
- 無益性を誰がどう判定するか（無益と「認識された」割合と、無益である割合は別物）
- 家族の心理的アウトカムを改善できる介入があるか
- 高齢ICU患者の意思決定（強い推奨はゼロ）
- パンデミック時のトリアージ・資源配分の枠組み

§14 カルテ記載の文例 — 結論だけでなく、範囲と過程を残す

DNARの有無だけを書いた記録では、合意の範囲も理由も夜勤の看護師に伝わりません。4学会合同ガイドラインが記録を求める項目（患者の意思、推定意思の根拠、考慮する時期とその根拠、最善の選択肢の検討内容、検討に加わったメンバー）と、DNARの適用範囲を書きます [4学会GL2026]。以下は一般論としての文例で、施設の様式に合わせて直して使います。`[ ]` は症例ごとに書き換える箇所です。

この章のポイント

1. DNARは「心停止時は原因を問わず」と範囲で書く
2. 面談記録には本人の言葉・推定意思の根拠・医療者の推奨を残す
3. TLTは目的・期間・評価項目・次の一手を先に書く

14-1. 文例1 — DNAR指示の範囲

文例1：DNAR指示（範囲を明示する）

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）
・適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。
・例外：**[内視鏡／CV挿入など]**処置に伴う心停止の扱いは、処置前に本人・家族等と確認する。
（今回の取り決め：**[処置中はDNARを一時解除し蘇生を行う／解除しない]**。蘇生後に本人の望む状態に戻れないと判断した場合は、生命維持治療の終了を検討する）
・DNARを理由に控えない治療：酸素投与、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**[NIV]**などは適応に応じて継続する。
・心停止前の治療の方針（DNARとは別に決定）：呼吸不全時の気管挿管**[行う／行わない／TLTとして行う]**、透析**[…]**、ICU入室**[…]**
・再評価：**[病状が変化したとき／○月○日／処置の前]**

「原因を問わず」「窒息を含む」「処置に伴う心停止は事前に決める」は、ガイドラインのルールではなく実装の一案です（§6）。

14-2. 文例2 — 面談記録（意思決定の過程）

文例2：意思決定の過程（面談記録）

【面談】**［日時］［場所］**
参加者：本人**［参加／不参加（理由：鎮静中など）］**、家族等**［氏名・続柄］**、医師**［氏名］**、看護師**［氏名］**、**［MSW・薬剤師など］**

1. 病状の説明
［病名・経過］を説明した。見通しは**［数日〜数週／数週〜数か月］**の単位で伝えた。
家族等の理解：「**［家族の言葉］**」

2. 本人の価値観・意向
［本人の言葉／家族等が語った本人の言葉］：「**［楽しみ・生きがい・こうなったら生きていたくない状態など、できるだけ逐語で］**」
推定意思の根拠：**［以前の会話・ACP・書面・普段の生活ぶり］**
→ 治療・ケアのゴール：**［苦痛を最小限にして家族と過ごす／自宅に帰れる可能性があれば治療を続ける　など］**

3. 医療・ケアチームの推奨と合意
上記のゴールに照らして、心停止時の心肺蘇生は**［利益がなく苦痛を増やす可能性が高い］**と判断し、行わないことを推奨した。
提案の形：**［informed assent／informed nondissent／推奨し意見を求めた］**。家族等が決定を医療者に委ねたいことを**［確認した］**。
家族等の反応：**［異議なし／同意／保留（理由）］**。質問：**［内容と回答］**

4. チームでの臨床倫理的検討
医学的側面：**［予後・フレイル（CFS ○）・治療の見込み］**
本人の意向：**［上記2］**
QOL：**［回復した場合に予想される状態］**
周囲の状況：**［家族の状況・意見の相違の有無］**

5. 決定事項と保留事項
決定：**［DNAR（文例1の範囲）／挿管は行わない／…］**
保留：**［透析は次回の面談で］**
再評価：**［○月○日、または状態が変化したとき］**

14-3. 文例3 — TLT

文例3：TLT（期限付きの治療の試行）

【TLT】
・目的（本人のゴールとの関係）：**[人工呼吸から離脱し、会話できる状態に戻ること]**
・試行する治療：**[気管挿管・人工呼吸／CRRT]**
・期間：**[7日間]**（再評価日：**[○月○日]**）
・評価項目：**[酸素化の指標・昇圧薬の量・意識レベル・新たな臓器障害]**
・改善した場合：**[継続して、○日後に再評価]**
・改善しない／悪化した場合：**[生命維持治療の終了を含め、ゴールに沿った方針を家族等と話し合う]**
・合意した参加者：**[氏名・続柄・職種]**

14-4. 文例4 — 本人の意思によるDNAR

文例4：本人が自分の価値観で蘇生を望まない場合（終末期でなくても）

本人**[意思決定能力あり：理解・認識・論理的思考・選択の表明を確認]**より、「**[本人の言葉]**」との意思表示あり。病状と、蘇生した場合に予想される経過を説明したうえで、本人の価値観に基づく選択として、心停止時の心肺蘇生を行わない（DNAR、文例1の範囲）。
家族等**[氏名]**と共有**[済／未（予定）]**。

終末期でなくても、本人には生命維持治療を受けるかどうかを選ぶ権利があります [4学会GL2026]。意思決定能力は決定ごとに確かめます（§4）。

14-5. 記録で避けること

！記録で避けること

- 「急変時DNR」「DNR取得」— 範囲が曖昧で、急変時に治療全般を控える読み方を招く
- 「家族がDNARを希望」だけを書く — 本人の価値観・推定意思の根拠・医療者の推奨がないと、何を合意したのかが残らない
- チェック欄だけで済ませる — DNARの有無だけでは、合意の範囲と理由が伝わらない

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。

1. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会 編. 救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）. 2026年9月.

2. 会田薫子, 小豆畑丈夫, 新井隆男, ほか（日本救急医学会 高齢者救急委員会）. 日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念. 日救急医会誌. 2025;36:82-90.
3. 日本集中治療医学会 倫理委員会. DNAR指示のあり方についての勧告. 日集中医誌. 2017;24:210-215.
4. 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018年3月改訂.
5. 日本集中治療医学会 倫理委員会. DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）の考え方（委員会報告）. 2016.
6. American Heart Association. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care: Ethics. Circulation. 2025. PMID 41122890.
7. Hamlyn J, et al. Frailty and outcomes after cardiopulmonary resuscitation: systematic review. 2022. PMID 35812717.
8. Ibitoye SE, et al. Frailty status predicts futility of cardiopulmonary resuscitation in older adults. PMID 32500916.
9. Yamamoto R, et al. Clinical Frailty Scale and outcomes after out-of-hospital cardiac arrest（SOS-KANTO 2017）. Ann Emerg Med. 2023. PMID 36964008.
10. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine.（4分割表）
11. Society of Critical Care Medicine. Fundamental Critical Care Support（FCCS）. 倫理の章.
12. Ganzini L, Volicer L, Nelson WA, Fox E, Derse AR. Ten Myths About Decision-Making Capacity. J Am Med Dir Assoc. 2004;5:263-267.
13. Secunda K, Wirpsa MJ, Neely KJ, et al. Use and Meaning of "Goals of Care" in the Healthcare Literature. J Gen Intern Med. 2020;35(5):1559-1566.
14. Lu E, Nakagawa S. A "three-stage protocol" for serious illness conversations: reframing communication in real time. Mayo Clin Proc. 2020;95(8):1589-1593.
15. 『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社; 2024.（本文の［ACP書籍2024］）
16. Curtis JR, Kross EK, Stapleton RD. The Importance of Addressing Advance Care Planning and Decisions About Do-Not-Resuscitate Orders During Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). JAMA. 2020;323(18):1771-1772.
17. Elwyn G, Laitner S, Coulter A, et al. Implementing shared decision making in the NHS. BMJ. 2010;341:c5146.
18. Auriemma CL, et al. JAMA Intern Med. 2022.
19. Tarcy T, Kallel H, Giffard M, et al. Decision-making process during limitation life-sustaining support meetings in French intensive care units. Intensive Care Med. 2022.
20. Burns JP, Truog RD. The DNR Order after 40 Years. N Engl J Med. 2016.
21. Sprung CL, Ricou B, Hartog CS, et al. Changes in End-of-Life Practices in European Intensive Care Units From 1999 to 2016（Ethicus-2）. JAMA. 2019.
22. Quill TE, Holloway R. Time-Limited Trials Near the End of Life. JAMA. 2011;306(13):1483-1484.
23. Rusinova K, Rusina R, Pantilat SZ. Understanding the neuroscience of communicating serious news. Intensive Care Med. 2026.
24. Baile WF, Buckman R, Lenzi R, et al. SPIKES—A six-step protocol for delivering bad news. Oncologist. 2000;5(4):302-311.
25. Jabaley CS, Brummell Z, Benoit DD, et al. Conflict in intensive care units: a conceptual framework for patient, family, team, and inter-service disagreement. Crit Care. 2026.
26. White DB, Angus DC, Shields AM, et al. A Randomized Trial of a Family-Support Intervention in Intensive Care Units. N Engl J Med. 2018;378(25):2365-2375.
27. Kentish-Barnes N, Chevret S, Valade S, et al. A three-step support strategy for relatives of patients dying in the intensive care unit: a cluster randomised trial. Lancet. 2022.
28. Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Family-Centered Care for Adult ICUs: 2024. Crit Care Med. 2025;53(2):e465-e482.

29. Fontenot T, Grisel B, Freeman J, et al. Ethical Implications of the Slow Code: A Systematic Review of Ethics of Slow Codes in U.S. Hospitals. Crit Care Med. 2026;54.
30. Ajzenberg H, Oczkowski SJW. Slow Codes—It's Time for an Honest Approach. Crit Care Med. 2026;54.
31. Wasserman JA, Crutchfield P. Time-limited trials are not an ethical compromise for physiologically futile CPR. Crit Care. 2026.
32. Khayat Kakhki S, Daneshfar M, NamaeiQasemnia A, et al. Reimagining resuscitation ethics: a narrative review and emergent ethical pathways model. Resusc Plus. 2026;29:101323.
33. Benoit DD, De Pauw A, Jacobs C, et al. Coaching doctors to improve ethical decision-making in adult hospitalized patients potentially receiving excessive treatment（CODE）. Intensive Care Med. 2024;50:1635-1646.
34. Hesselink G, Ramakers B, Fikkers BG, et al; PICNL-ICU Study Group. Crit Care Med. 2026;54.
35. Brender TD, Axelrod JK, Weiss Goitiandia S, et al. Clinicians' Perceptions About Institutional Factors in Moral Distress Related to Potentially Nonbeneficial Treatments. JAMA Netw Open. 2025;8(6):e2516089.
36. Le Dorze M, Nicolas-Robin A, Carvallo S, et al. Death determination at the bedside: clinical judgement beyond criteria. Crit Care. 2026.
37. Choi HR, Zhu L, Lo MS, et al. Family members' experiences of death and organ donation in intensive and critical care units: a qualitative systematic review with thematic synthesis. Crit Care. 2026.
38. Oppenheim IM, Bakhru RN, Maciel CB, Busl KM; DONOR Group. Crit Care Explor. 2026;8(8):e1458.
39. Wu A, Hirsch KG, Magnus D. Communicating With Families About Brain Death. JAMA. Published online September 2, 2026.
40. Taccone FS. Ableism in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2023;49(7):898-899.
41. Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc Sci Med. 1999;48(8):977-988.
42. Beil M, Jung C, Guidet B. Negotiating complexity in spite of scarce evidence—how to care for older ICU patients? Intensive Care Med. 2026;52(8):1793-1795.
43. Ueno R, Modra L, Warrillow S. Culture, ethics and clinical practice for intensivists managing end of life care: an Australian perspective. J Intensive Care. 2026;14:19.
44. Kesecioglu J, Metaxa V, Azoulay E. Surviving Sepsis Campaign beyond survival: aligning sepsis care with patient goals. Intensive Care Med. 2026.

最終更新日：2026-10-14（「最新の動き」は随時更新）